**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS · FACULDADE DE MEDICINA**

# Avaliação Oficial P1 · Diretrizes Clínicas & Conduta

Disciplina/Assunto: Cardiologia · Diretriz SBC de Insuficiência Cardíaca & HAS | Docente: Prof. Dr. Otto

Data: 21/10/2026 | Modelo: CLASSICO | Versão: CADERNO ALFA

**OTTO.**

**ALUNO(A):** _____ **MATRÍCULA:** _____ **NOTA:** _____

**CARTÃO OMR (PREENCHA TOTALMENTE A BOLHA PARA CORREÇÃO POR FOTO NO OTTO):**

**Q1:** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

**QUESTÃO 01 · [ICFER · TERAPIA MODIFICADORA] · MÚLTIPLA ESCOLHA (1.5 pt)**

Segundo a Diretriz da SBC, qual combinação farmacológica representa os quatro pilares fundamentais que reduzem mortalidade na ICFER (FEVE <= 40%)?

(A) Digoxina, furosemida, anlodipino e hidroclorotiazida.

(B) Sacubitril-valsartana (ou IECA), betabloqueador, espironolactona e inibidor de SGLT2 (dapagliflozina/empagliflozina).

(C) Tartarato de metoprolol, losartana baixa dose e amiodarona.

(D) Furosemida isolada e ácido acetilsalicílico.

(E) Hidralazina, verapamil e clortalidona.

**QUESTÃO 02 · [DISSERTATIVA · MANEJO DO PERFIL B] · DISSERTATIVA CONCEITUAL (2.0 pt)**

Paciente com IC crônica descompensada dá entrada em Perfil B (quente e úmido) em uso de carvedilol. Descreva a conduta de descongestão e o manejo do betabloqueador.

# GABARITO OFICIAL & ESPELHO DE CONCEITOS (OTTO.) · CADERNO ALFA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS · FACULDADE DE MEDICINA · Avaliação Oficial P1 · Diretrizes Clínicas & Conduta · Data: 21

## Questão 01 [Múltipla Escolha] · GABARITO: (B)

Justificativa/Diretriz: Quarteto fantástico da ICFER: INRA/IECA + Betabloqueador + Espironolactona + iSGLT2.

## Questão 02 [Dissertativa · Correção por Conceito & Palavras-Chave]

Conceito-Alvo: Descongestão com furosemida EV + vasodilatador endovenoso, mantendo-se o betabloqueador na ausência de choque.
Palavras-Chave Obrigatórias: furosemida, diuretico de alca, vasodilatador, manter betabloqueador, quente e umido